

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5081859-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: WALTER PEREIRA DA SILVA FILHO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO ONCOLÓGICOPRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE DEFERIMENTO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5081859-41.2024.4.02.5101

510014823905 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5081859-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: WALTER PEREIRA DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela União Federal a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada, na forma da decisão recorrida, que determinou que os réus providenciem io agendamento da consulta ambulatório 1ª VEZ - COLOPROCTOLOGIA (ONCOLOGIA).

Em suas razões recursais, a União alega ausência de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Sustenta que não cabe ao Judiciário escolher quem será tratado em primeiro lugar. Requer o efeito suspensivo e o inteiro provimento do recurso para a cassação da antecipação dos efeitos da tutela, ou, em caso de manutenção da decisão, o direcionamento do cumprimento da ordem judicial ao Estado.

Sem contrarrazões.

Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, “sic”:

“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.”

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;(...)

Nos casos específicos de doenças oncológicas, a Lei 13.896/2019 promoveu alteração na Lei 12.732/2012, dispondo que exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna devem ser realizados no prazo de 30 (trinta) dias, o que só reforça o reconhecimento da necessidade de rápido diagnóstico para imediato tratamento, dentro do prazo de 60 dias previsto no art. 2º da Lei 12.732/2012, *in verbis*:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3º Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei nº 13.896, de 2019) (Vigência)

No caso em tela, o autor realizou colonoscopia em 16/04/2024 (ev. 1, anexo2, fl. 14), na qual se colheu material para biópsia, cuja conclusão, na data de 20/04/2024, foi de colite crônica acentuada ulcerada, com necessidade de prosseguir com a investigação (ev. 1, anexo2, fl. 13).

Não obstante, somente em 06/07/2024, quando o autor procurou a emergência do CER da Barra da Tijuca (ev. 1, anexo2, fl. 14), passou-se a tomar providências a fim de confirmar o diagnóstico e definir o tratamento adequado.

Em 09/07/2024, o autor foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar a fim de realizar o procedimento de transversostomia em alça, por conta de obstrução intestinal, havendo expressa recomendação para agendamento da consulta oncológica - "ambulatório de uro-oncologia", em 12/07/2024 (ev. 1, anexo2, fl. 15).

Apesar do quadro apresentado, apenas em 21/08/2024 o autor foi inserido no sistema de regulação para a consulta ambulatório 1ª vez - coloproctologia (oncologia), conforme atesta o ev. 1, anexo2, fls. 32/33.

Na data de 08/10/2024, após verificação junto à Central de Regulação, constatou-se que a classificação de risco do paciente é vermelha, ocupando ainda a posição 307ª na fila para o atendimento oncológico (ev. 3).

Destaca-se, ainda, que a demora no início do tratamento adequado pode comprometer o quadro clínico do paciente, configurando, portanto, o *periculum in mora*, circunstância já materializada pelo documento médico do ev. 1, anexo2, fls. 16/17, que, na data de 23/09/2024,

identificou metástase óssea.

Superada estas questões, verifico que, mediante análise meramente perfunctória, encontro na exposição da lide a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada deferida pelo Juízo *a quo*.

O deferimento do efeito suspensivo tem por objetivo impedir a ocorrência de dano de difícil reparação até o pronunciamento definitivo do colegiado.

Nesse contexto, analisando o presente caso não vislumbro qualquer possibilidade de dano irreparável à recorrente, cujas razões recursais apenas atacam o provimento antecipatório sem demonstrar fatos hábeis que pudessem afastar a verossimilhança da pretensão autoral.

Constato, ao reverso, que o risco de dano irreparável corre em prejuízo da Recorrida, diagnosticada com câncer de bexiga / carcinoma urotelial de baixo grau, que necessita da avaliação em uro-oncologia com o respectivo tratamento oncológico e o procedimento de nefrostomia com ou sem drenagem, em caráter de urgência, sob risco de evolução do seu quadro clínico, não tendo o recorrente juntado prova hábil e suficiente a ilidir as conclusões do Juízo *a quo*.

Portanto, vislumbro preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC e entendo que os argumentos da União não são suficientes a gerar a revisão de plano da referida decisão.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.